

Apendicite aguda · diagnóstico e conduta

Dor migratória, anorexia e sinais de irritação em FID ainda são o núcleo. Imagem confirma quando a clínica é dúbia; conduta padrão no adulto típico é apendicectomia.

Quadro clássico

- Dor periumbilical !' FID (ponto de McBurney)
- Anorexia, náusea/vômito após a dor
- Febre baixa a moderada; Blumberg / Rovsing / psoas conforme posição
- Leucocitose com desvio; PCR pode apoiar, não fecha sozinha

Imagem — quando e qual

Cenário | Preferência

Criança / magro / gestante | USG como 1ª linha

Adulto com dúvida | TC com contraste (alta acurácia)

Gestante com USG inconclusivo | RM se disponível

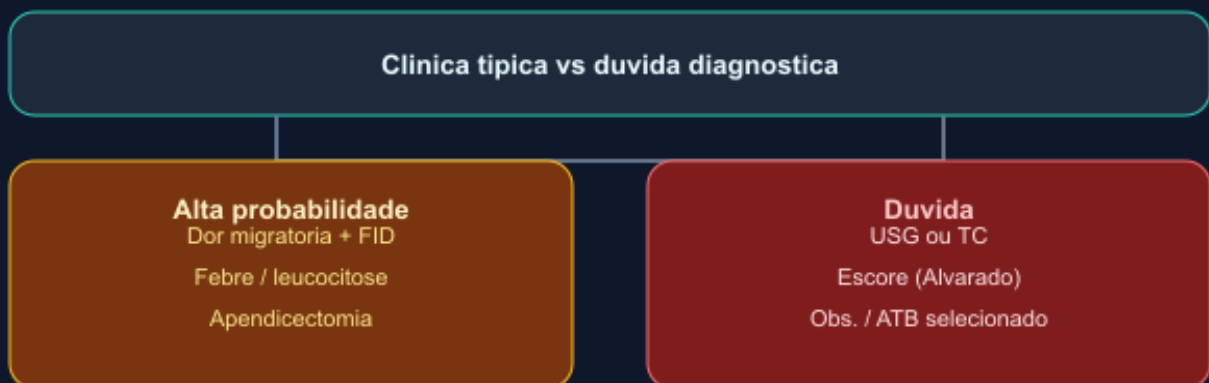
Plastrão / abscesso

Dica - Plastrão / abscesso

Apendicite complicada com plastrão pode receber ATB ± drenagem e apendicectomia intervalada conforme protocolo — não force cirurgia 'a frio' em todo abscesso.

Ramificação de prova: alta probabilidade !' cirurgia; dúvida !' imagem e reavaliação.

Apendicite suspeita



Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Em idosos e imunossuprimidos a clínica é atípica e a perfuração é mais precoce. Dor 'leve' + sepse abdominal !' imagem e cirurgia sem demora.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1